

DOLOR TORÁCICO Y PALPITACIONES

Melo Octavio Jiménez. Pablo Legarra Oroquieta.

DOLOR TORÁCICO

INTRODUCCIÓN

El dolor torácico es un motivo de consulta en Urgencias muy frecuente, y suponen un reto diagnóstico, ya que puede ser la expresión de un espectro clínico muy amplio, que va desde una etiología banal, hasta enfermedades con alta morbilidad como es el síndrome coronario agudo (SCA), síndrome aórtico agudo (SAA), tromboembolismo pulmonar (TEP), entre otros. Saber dar valor a la gravedad del síntoma resulta muy difícil incluso para personal experimentado lo cual puede llevar a infradiagnosticar patologías graves o por contrario, a la solicitud de pruebas diagnósticas o ingresos no indicados. En este capítulo se pretende dar las herramientas necesarias para el enfoque y diagnóstico inicial del dolor torácico como síntoma, siendo desarrolladas las diferentes patologías que lo originan en su capítulo correspondiente.

DIAGNÓSTICO

Historia clínica

Una cuidadosa anamnesis es clave en el diagnóstico o enfoque inicial del dolor torácico que, junto a la exploración física, ayuda a confirmar la sospecha clínica y descartar diagnósticos menos probables.

En un primer momento es importante que el paciente comente libremente lo sucedido “dígame que ha pasado”, evitando preguntas dirigidas tipo “¿era una presión en el pecho?”. Después se deben realizar preguntas directas para enfocar el diagnóstico. Como regla nemotécnica, en la historia clínica deben constar las siguientes características del dolor: **“ALICIA DRA”**.

Punto clave:

- En todos los casos se debe interrogar y describir en la historia clínica todas las características del dolor.
- **Aparición:** días, horas, meses, asociar a temporadas o fechas tradicionales. También reflejar los desencadenantes (ej: tras subir una cuesta, en reposo, con esfuerzos habituales, tras cambios de posturas, después de las comidas, al toser, etc.).
- **Localización:** ¿a punta de dedo? ¿puño cerrado?, ¿difuso? (útil que lo señale con su mano).
- **Irradiación:** brazos, cuello, espalda, mandíbula.
- **Características y Concomitantes (síntomas asociados):** Cólico, quemante, sordo, opresivo, pulsátil, neurálgico, punzante. Los concomitantes o síntomas asociados son de importancia por ejemplo síntomas vegetativos (sudoración náuseas en el origen isquémico), disnea (por ejemplo en TEP o neumotórax), disfagia (espasmo esofágico), palpitaciones, síncope, fiebre.
- **Intensidad:** es útil la escala EVA de dolor (0 al 10) donde 0 es ausencia de dolor y 10 es un dolor de características insoportables.
- **Duración:** segundo, minutos, horas, semanas.
- **Recidiva:** recurrencia del síntoma con esfuerzos, ingestas, posturas. Si el paciente ha tenido episodios previos (por ejemplo angina, traumatismo, cólico biliar) preguntar si le recuerda a dicho dolor.
- **Alivio:** Cese del dolor en reposo, al cambiar de postura, tras la comida, fármacos (AINEs,

nitratos, antiácidos).

PUNTO CLAVE

- Existe poca correlación entre intensidad del dolor y gravedad del cuadro en muchas de las patologías.

Exploración física

Fundamental valorar las constantes del paciente (tensión arterial, debe ser tomada en ambos brazos si sospecha de SAA, frecuencia respiratoria, saturación de O₂, temperatura y frecuencia cardíaca) y el estado general: nivel de consciencia, grado de perfusión, hidratación. Estos dos elementos nos permitirán en un primero momento establecer la urgencia vital del paciente y por tanto su ubicación en las áreas de Urgencias.

PUNTO CLAVE

- Las constantes vitales y el estado general del paciente nos permitirán orientar rápidamente el riesgo vital que supone la patología.
 - **Exploración vascular y extremidades.** Ingurgitación yugular (insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco), característica y simetría de pulsos de carotídeos y en extremidades (asimétricos en SAA, coartación de aorta, “saltón” en insuficiencia aórtica), soplo carotídeo (irradiación de valvulopatía aórtica). Edema en extremidades inferiores (insuficiencia cardíaca), signo de trombosis venos profunda (dolor torácico por TEP).
 - **Tórax:** inspección en búsqueda de lesiones cutáneas (traumatismos, hematomas, herpes zóster), asimetría en la expansión (neumotórax), utilización de musculatura accesoria. Palpar el tórax (dolor a la palpación que reproduce el dolor, tórax inestable en traumatismos). Auscultación cardíaca (soplos por valvulopatía, roce pericárdico, extratonos como tercer o cuarto ruido) y pulmonar (crepitantes unilaterales por neumonía, bilaterales por insuficiencia cardíaca, hipoventilación por neumotórax o hipofonía por derrame pleural).
 - **Abdomen:** nos permitirá descartar causas no torácicas como pancreatitis, cólico biliar, dolor epigástrico por úlcera gástrica.
- Tras realizar la anamnesis y la exploración física podremos establecer perfiles clínicos de dolor torácico:

PERFIL ISQUÉMICO: generalmente es un dolor opresivo, que se localiza en tórax en la región retroesternal y se irradia a brazos, mandíbula o escápula y suele estar acompañado de síntomas vegetativos. Generalmente se relaciona con esfuerzo, estrés emocional o comida copiosa, típicamente alivia con el reposo o con nitratos (aunque hay otras patologías que pueden mejorar tras nitratos como el espasmo esofágico). Si es intermitente, la duración suele ser menos de 20 minutos; y si persiste más tiempo, siempre habrá que descartar un SCA. Un dolor que dure segundos no es sugestivo de origen isquémico.

PUNTOS CLAVES

- La reducción del dolor tras NTG puede llevar a confusión y no se debe considerar como única maniobra diagnóstica. La reproducción del dolor con la palpación tampoco debe ser una maniobra diagnóstica en pacientes con sospecha de dolor torácico de origen isquémico ya que pueden coexistir isquemia y dolor osteomuscular.

PERFIL PLEURÍTICO: dolor punzante, generalmente de localización costal unilateral o en región escapular y no suele exacerbarse con palpación. Aumento con inspiración profunda o tos. Suele ser la manifestación de patología pleural como derrame pleural, neumonía, TEP o neumotórax.

PERFIL PERICÁRDICO: Dolor de características pleuríticas, punzante, de horas o días de duración, que se puede irradiar hacia cuello (esternocleidomastoideo) y que típicamente empeora con el decúbito y mejora con la sedestación o antiinflamatorias. Puede asociar fiebre, antecedentes de síndrome gripal o roce pericárdico a la exploración.

PERFIL ESOFÁGICO: Dolor tipo ardor, subesternal o epigástrico; de entre 10-60 minutos de duración. Empeora con el decúbito postprandial, cede con los antiácidos. El espasmo esofágico suele ser de menor duración, opresivo, retroesternal y que cede con nitratos, muy similar al dolor anginoso, pero suele asociar disfagia.

PERFIL AÓRTICO: Dolor súbito, muy intenso, a menudo tras un esfuerzo, definido como “sensación de desgarrar” en el pecho o abdomen que se puede irradiar a espalda. Suele asociar sensación de gravedad, sudoración profusa, hipotensión o asimetría de pulsos. Según la extensión, puede presentar déficit neurológico (afectación troncos supraaórticos), isquemia de miembros, dolor de perfil isquémico (disección coronaria), soplo e insuficiencia cardíaca aguda (afectación de válvula aórtica), dolor abdominal (aorta abdominal), entre otros.

PERFIL TROMBOEMBÓLICO: Dolor de comienzo brusco, de presentación variable, generalmente asociado a disnea. Puede ser de características pleuríticas y unilateral (del lado de la embolia), asintomático (en TEP pequeños) o de características isquémicas (en TEP masivos y con inestabilidad hemodinámica). Suele acompañarse además de taquipnea, taquicardia, síncope e hipotensión según la gravedad.

PERFIL PSICÓGENO: cuadros emocionales y psiquiátricos. Presentación variable y con factores situacionales / emocionales desencadenantes.

PERFIL MUSCULAR: por lo general bien localizado, “a punta de dedo”, tipo punzante y suele reproducirse con la palpación en la zona afecta y modificarse (alivio o empeoramiento) con los movimientos.

Pruebas complementarias

ECG: se debe realizar un ECG de 12 derivaciones en menos de 10 minutos desde la llegada del paciente con dolor torácico, añadiendo derivaciones posteriores y derechas según la sospecha clínica.

PUNTO CLAVE

- La alteración electrocardiográfica puede estar presente sólo cuando hay dolor, por lo que un ECG basal normal no descarta origen isquémico y habrá que repetirlo a los pacientes con alta sospecha clínica.

ANALÍTICA GENERAL:

Se debe individualizar la solicitud a cada paciente y a la sospecha clínica.

- **Hemograma** con fórmula leucocitaria.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, GOT, GPT, LDH, Amilasa, PCR, NT-proBNP, CK, troponina ultrasensible (si se sospecha de etiología isquémica o pericárdica).

- **Coagulación básica.** Solicitar Dímero D en caso de sospecha de TEP o SAA.
- **Gasometría arterial.** Si disnea o sospecha de neumonías graves, edema agudo de pulmón.
- **Radiografía de tórax.** Se debe realizar a todos los pacientes, pues puede aportar claves en el diagnóstico y/o exclusión de patologías. Se debe valorar: índice cardior torácico, ensanchamiento mediastínico (SAA); valoración pleuropulmonar (derrame pleural, condensaciones, infiltrados, patrón intersticial, atelectasias, neumotórax, etc); estructuras óseas (fracturas, lesiones degenerativas).
- **Otras.** Según la sospecha etiológica, puede ser necesario un **ecocardiograma** (para descartar cardiopatía estructural, derrame pericárdico, anomalías de la contractilidad que sugieran isquemia, etc), un **angio-TAC** (en sospecha de SAA o TEP), **ecografía abdominal** (en sospecha de patología a ese nivel irradiada a tórax), etc.

TRATAMIENTO

Finalmente, cada patología que origina dolor torácico cuenta con sus propios CRITERIOS de ingreso, tratamiento ambulatorio, observación en Urgencias, etc. De manera general, podemos orientar la decisión según la gravedad del cuadro:

- **Riesgo vital para el paciente:** mantener monitorizado en box de críticos de Urgencias, UCI, reanimación.
- **Riesgo no vital para el paciente:** ingreso en planta, área de observación de Urgencias, unidad de dolor torácico, alta a domicilio con tratamiento médico y cita en consultas.
- **Poco riesgo para el paciente:** alta a domicilio con tratamiento, consultas externas.

PALPITACIONES

INTRODUCCIÓN

Las palpitaciones son la percepción del latido cardíaco por parte del paciente. Al igual que otros síntomas, la descripción de la palpitación es muy variable y la puede referir como “golpe del corazón”, “se va a salir el corazón”, “como un tren”, “como un vuelco”, etc. La palpitación puede estar relacionada directamente con:

- **Causa cardíaca:** patología estructural cardíaca (valvulopatías, disfunción ventricular, dilatación auricular, miocardiopatías, etc). También pueden aparecer en corazones morfológicamente sanos.
- **Causas extracardíacas:** hipertiroidismo, uso de estimulantes (taurina, cafeína, cocaína), estados hipercatecolaminérgicos (ejercicio, ansiedad o feocromocitoma).

Clínica

Es importante describir el tipo de palpitaciones (latido aislado tipo extrasístole, racha de latidos rápidos, regularidad, comienzo y fin súbitos o paulatinos), lugar (región centrotorácica, cuello o ambas), además de desencadenantes (ejercicio, bebidas, reposo, etc) , frecuencia de aparición y los síntomas acompañantes (mareos, síncope, dolor torácico, disnea).

Considerando las causas mencionadas, las palpitaciones pueden deberse a causas benignas como extrasístoles aisladas o a causas que implican un riesgo para el paciente como disfunción ventricular, miocardiopatía hipertrófica, fibrilación auricular paroxística. Se debe tener en cuenta la comorbilidad del paciente para el enfoque del diagnóstico y la probabilidad de arritmias graves.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico se debe realizar:

- En Urgencias, se debe **monitorizar al paciente con telemetría**
- **ECG de 12 derivaciones y tira de ritmo**, especialmente interesante durante los síntomas, pues puede ser normal en ausencia de los mismos.
- **Hemograma** con fórmula leucocitaria.
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, GOT, GPT, Amilasa, PCR, NT-proBNP, CK, troponina ultrasensible (si se sospecha de etiología isquémica o pericárdica).
- **Coagulación básica.**
- **Radiografía de tórax.**

Realizar una analítica básica (descartar trastornos hidroelectrolíticos, anemia, hormonas tiroideas) y realizar una radiografía de tórax, nos ayuda a descartar causas secundarias.

Si los síntomas persisten o no hay diagnóstico, se debe remitir a consulta de Cardiología para estudio. Entre las pruebas disponibles se puede realizar un holter-ECG de 24 horas (rentabilidad baja si los síntomas son ocasionales), un holter de larga duración o incluso el implante de holter insertable. También es interesante la realización de un ecocardiograma para descartar cardiopatía estructural y, a veces, una ergometría para valorar el comportamiento de las arritmias con el esfuerzo. Finalmente, se puede realizar un estudio electrofisiológico, con intención diagnóstica y/o terapéutica.

TRATAMIENTO

Una vez descartadas causas desencadenantes, se puede valorar tratamiento con betabloqueantes si son muy sintomáticas o están asociadas a disfunción ventricular.

BIBLIOGRAFÍA

- Ibañez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018; 39(2):119-177.
- Roffi M, Patrono C, Collet JP, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting without Persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 37(3):267-315.
- Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison. Principios de Medicina Interna. 19ª ed. España: Mc Graw Hill Castellano; 2016.
- Braunwald E, Mann D, Zipes D, Libby P, Bonow R. Tratado de Cardiología. 10ª ed. España: Elsevier; 2016.
- Torbal A, Boersma E, Jors JA, Van Herpen G, Deckers JW, Van der Kuip DA et al. Incidence of recognized and unrecognized myocardial infarction in men and women aged 55 and older: the Rotterdam Study. Eur Heart J. 2006;27(6):729-736.
- Bassan R, Gibler WB. Unidades de dolor torácico: estado actual del manejo de pacientes con dolor torácico en los servicios de urgencias. Rev Esp Cardiol. 2011;54(9):1103-1109.
- Martínez-Sellés M, Bueno H, Sacristána A, Estévez A, Ortiz J, Gallego L et al. Dolor torácico en urgencias: frecuencia, perfil clínico y estratificación de riesgo. Rev Esp Cardiol. 2008;61(9):953-959.

VIDEO

<https://youtu.be/KJhuzvp3aB0> <https://youtu.be/HcEMTTJa6Uw> <https://youtu.be/APgHblUSj4>
<https://youtu.be/q151O0LtuvE> <https://youtu.be/6Fp5KovzUaw>